BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN Phòng Điều dưỡng	QUY TRÌNH CHUẨN (SOP) THEO DÕI, BÁO ĐỘNG SỚM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ DIỄN BIẾN NẶNG (NEWS2)	Mã số: SOP-A4.1-02 Lần ban hành: 01 Ngày hiệu lực: …/…/2026 Số trang: theo bản in

	Người biên soạn	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ tên			
Chức danh	Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng	Trưởng phòng Điều dưỡng	Giám đốc
Chữ ký			
Ngày			

Lần	Ngày	Nội dung sửa đổi
01		Ban hành lần đầu

DỰ THẢO

1. Mục đích

Phát hiện sớm người bệnh nội trú xấu đi và bảo đảm bác sĩ được báo, đến đánh giá trong thời gian quy định; khắc phục các sự cố chậm trình bác sĩ, chậm xử trí năm 2026.

2. Phạm vi

Người bệnh người lớn nội trú tại các khoa lâm sàng (trừ sản phụ). Khoa Nhi, Khoa Phụ sản dùng công cụ cảnh báo riêng phù hợp đối tượng.

3. Bảng điểm NEWS2 (Royal College of Physicians, Vương quốc Anh, 2017)

Thông số	3	2	1	0	1	2	3
Nhịp thở (lần/phút)	≤ 8		9–11	12–20		21–24	≥ 25
SpO2 thang 1 (%)	≤ 91	92–93	94–95	≥ 96			
Thở oxy		Có		Không			
Huyết áp tâm thu (mmHg)	≤ 90	91–100	101–110	111–219			≥ 220
Mạch (lần/phút)	≤ 40		41–50	51–90	91–110	111–130	≥ 131
Ý thức				Tỉnh (A)			Mới lú lẫn, đáp ứng lời nói, đau, không đáp ứng
Nhiệt độ (°C)	≤ 35,0		35,1–36,0	36,1–38,0	38,1–39,0	≥ 39,1	

Ghi chú: *Thang SpO2 số 2 (đích 88–92%) dùng cho người bệnh suy hô hấp tăng CO2 theo chỉ định của bác sĩ. Bản dịch bảng điểm cần Hội đồng chuyên môn đối chiếu nguyên bản trước khi ban hành.*

4. Đáp ứng theo mức điểm

Tổng điểm	Tần suất đo tối thiểu	Hành động của điều dưỡng	Thời gian bác sĩ đến (mốc nội bộ)
0	Mỗi 12 giờ	Theo dõi thường quy	—
1–4	Mỗi 4–6 giờ	Báo điều dưỡng phụ trách ca; quyết định tăng tần suất	Khi điều dưỡng đề nghị
Một thông số được 3 điểm	Mỗi 1 giờ	Báo bác sĩ điều trị hoặc bác sĩ trực	≤ 30 phút
5–6	Mỗi 1 giờ	Báo bác sĩ khẩn, ghi giờ báo	≤ 30 phút
≥ 7	Theo dõi liên tục	Báo bác sĩ cấp cứu ngay; chuẩn bị phương tiện cấp cứu; cân nhắc chuyển HSTC	Ngay

5. Các bước thực hiện

Bước 1. Đo đủ 7 thông số mỗi lần theo dõi dấu hiệu sinh tồn; tính điểm trên BM-A4.1-03.

Bước 2. Thực hiện hành động theo mục 4; báo bác sĩ theo ISBAR (SOP-C6.1-02), ghi giờ báo, tên bác sĩ nhận.

Bước 3. Bác sĩ không đến trong thời gian quy định: báo lại và báo điều dưỡng trưởng hoặc trực lãnh đạo.

Bước 4. Kết quả cận lâm sàng bất thường (điện tim, xét nghiệm nguy hiểm) được trình bác sĩ ngay, không chờ đi buồng.

Bước 5. Bàn giao ca nêu rõ người bệnh có điểm NEWS2 ≥ 5 hoặc đang tăng.

6. Tiêu chuẩn đánh giá

- KPI-A4.1-06: Tỷ lệ NB nội trú có NEWS2 ≥ 5 được báo bác sĩ đúng thời gian 100%.
- Không có sự cố chậm báo bác sĩ gây hại.

7. Căn cứ, tài liệu tham khảo

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH).
- Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
- Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2. London: RCP, 2017.